

ATIVIDADE 1.1: Análise das Condições de Saúde da População e seus Determinantes a partir de Dados Secundários (Montes Claros - MG)

1. Introdução e Pergunta Disparadora

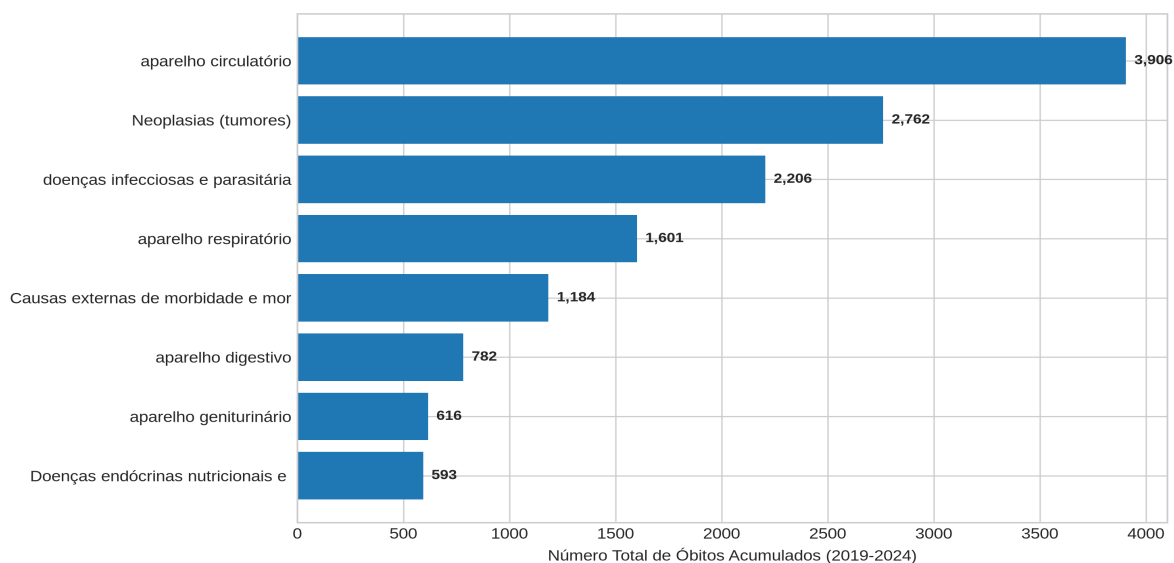
O presente documento tem como objetivo responder às questões norteadoras do Momento 1: *"De que adoece/morre a população? E por que a população adoece e morre por essas causas?"*. Para subsidiar a análise territorial na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família (USF), foram extraídos dados secundários oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) via TabNet, referentes ao município de Montes Claros/MG (Código IBGE: 314330), considerando o local de residência entre os anos de 2019 e 2024.

2. De que Morre a População de Montes Claros? (Perfil Epidemiológico)

No período de 2019 a 2024, foram registrados 15.374 óbitos de residentes em Montes Claros. A análise revela um padrão consolidado de transição epidemiológica com forte predomínio das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), somado a agravos externos e respiratórios:

Capítulo CID-10	2019-2024	%
IX. Doenças do Aparelho Circulatório	3.906	25,4%
II. Neoplasias (Tumores)	2.762	18,0%
I. Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias	2.206	14,3%
X. Doenças do Aparelho Respiratório	1.601	10,4%
XX. Causas Externas (Acidentes/Violência)	1.184	7,7%
XI. Doenças do Aparelho Digestivo	782	5,1%
XIV. Doenças do Aparelho Geniturinário	616	4,0%
IV. Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	593	3,9%
Demais Causas Somadas	1.724	11,2%
Total Geral	15.374	100%

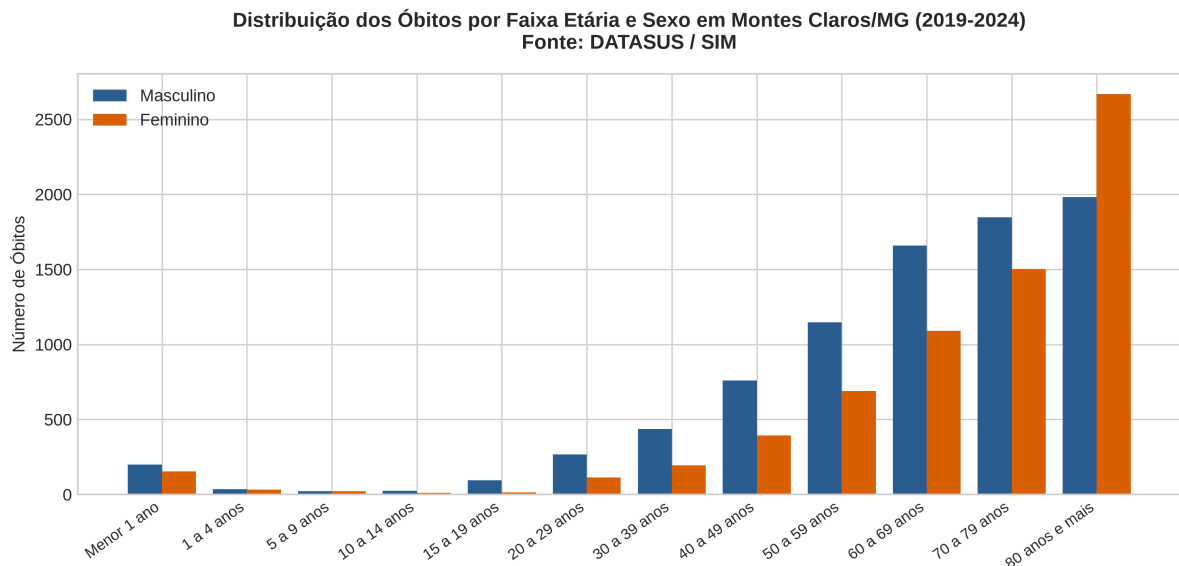
Principais Causas de Óbito em Montes Claros/MG por Residência (2019-2024)
Fonte: DATASUS / SIM



3. Perfil Sociodemográfico: Quem Morre em Montes Claros?

A distribuição por sexo e faixas etárias demonstra dois eixos críticos de vulnerabilidade:

- **Sobremortalidade Masculina Jovem (15 a 29 anos):** Na juventude, morrem entre 3 e 6 homens para cada mulher, com grande protagonismo de acidentes automobilísticos (principalmente motocicletas) e agressões violentas.
- **Envelhecimento Populacional (Idosos 60+):** Os idosos concentram 70% de todos os óbitos municipais, com predomínio feminino na faixa de 80 anos e mais (feminização da velhice) e alta carga de complicações vasculares e neoplásicas.



4. Por Que a População Adoece e Morre por Essas Causas? (Determinantes Sociais)

A análise das causas de mortalidade deve ser compreendida sob a ótica dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS - Dahlgren & Whitehead):

- Determinantes Socioeconômicos e Desigualdades Intraurbanas:** Montes Claros, embora polo econômico do Norte de Minas, possui expressiva desigualdade de renda e periferização. A baixa escolaridade e renda dificultam a adesão terapêutica contínua para hipertensão e diabetes e o autocuidado.
- Modos de Vida, Alimentação e Cultura:** Hábitos alimentares ocidentalizados (alto teor de sódio, açúcares e gorduras), tabagismo, sedentarismo e consumo abusivo de álcool elevam drasticamente o risco de infartos, AVC e cirrose. O uso intenso de motocicletas sem fiscalização adequada impulsiona os politraumatismos.
- Determinantes Ambientais e Sanitários:** O clima semiárido, caracterizado por períodos prolongados de seca e baixa umidade relativa do ar, predispõe a infecções respiratórias e descompensação de pneumopatias em idosos e crianças, além de desafios históricos na drenagem que favorecem surtos de arboviroses.
- Organização da Rede de Atenção à Saúde:** Barreiras no acesso de homens à APS (baixa adesão à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem) provocam diagnóstico tardio de doenças silenciosas. A sobrecarga de Montes Claros como sede polo regional pressiona os serviços de urgência e emergência.

5. Considerações e Recomendações para a Unidade de Saúde da Família (USF)

Esses achados secundários fornecem a base quantitativa necessária para o planejamento das ações da equipe da USF. Recomenda-se: fortalecimento do acompanhamento longitudinal de hipertensos e diabéticos (Hiperdia), ações intersetoriais de prevenção de acidentes e violência dirigidas a homens jovens, e qualificação

do rastreamento de cânceres prevalentes (colo uterino, mama, colorretal e próstata).